ONEMA-POP-014 — Versão institucional 1.0

Status: Aprovado pelo RT · Vigência: 09/11/2026 · Responsável técnico: Enf. Marcos Roberto Alves, COREN-SP 983558

1

ONEMA-POP-014 — Triagem de Suspeita de Reação Adversa a

Medicamentos e Alergia

1. Identificação institucional, código, título, versão e RT

ONEMA SAÚDE | ONEMA-POP-014 | Triagem de Suspeita de Reação Adversa a Medicamentos e Alergia | Versão

2. Objetivo e abrangência

Reconhecer reação adversa medicamentosa, diferenciar manifestação leve de anafilaxia e organizar encaminhamento seguro.

3. Competência, indicações e contraindicações

Enfermeiro habilitado, com treinamento e atuação dentro das competências profissionais. Suspeita de evento após início

ou alteração de medicamento; não realizar teste de provocação, reexposição ou suspensão definitiva sem decisão clínica,

exceto interromper administração em curso diante de reação suspeita.

4. Materiais, equipamentos e responsável pelo fornecimento

Paciente: embalagens, prescrição, lista de fármacos e horários; enfermeiro: equipamentos de sinais vitais, oxímetro, EPI, telefone de emergência e formulário de evento. Fornecimento pactuado no pedido e confirmado antes da visita.

5. Avaliação clínica e preparação

Verificar fármaco, dose, via, lote quando disponível, tempo desde exposição, histórico alérgico, sintomas cutâneos, respiratórios, cardiovasculares e gastrointestinais.

6. Execução técnica numerada e verificável

1. Confirmar identidade e avaliar imediatamente via aérea, respiração, circulação e nível de consciência.

2. Registrar horário de início, medicamento suspeito, dose, via e relação temporal; buscar outros agentes ou alimentos

envolvidos.

3. Se administração estiver em curso e houver suspeita de reação, interromper a administração e manter segurança do

paciente sem reexposição.

4. Procurar urticária generalizada, edema de língua/lábios, estridor, sibilância, dispneia, hipotensão, síncope ou vômitos

associados a sinais sistêmicos.

5. Na suspeita de anafilaxia, acionar SAMU 192 imediatamente e seguir protocolo de emergência e medicação de resgate

prescrita/disponível à equipe habilitada; não aguardar erupção cutânea.

6. Em manifestação aparentemente limitada, avaliar evolução, sinais vitais e possibilidade de progressão; contatar

prescritor para decisão terapêutica.

7. Registrar descrição objetiva e comunicar evento ao RT e aos canais de farmacovigilância aplicáveis, evitando rotular

toda intolerância como alergia confirmada.

7. Interrupção, intercorrências e encaminhamento

Anafilaxia, comprometimento respiratório, colapso circulatório, edema progressivo, lesões bolhosas ou mucosas, febre com erupção extensa: emergência.

8. Cuidados posteriores e orientações

Orientar paciente a guardar embalagens e informar a suspeita em atendimentos futuros; não reiniciar fármaco suspeito sem avaliação do prescritor.

9. Registros obrigatórios na Carteira Digital ONEMA

Identificação e consentimento; avaliação inicial e sinais vitais quando indicados; descrição objetiva, classificação/medidas,

intervenção, insumos, resposta, intercorrências, orientações, comunicação e plano de seguimento; assinatura profissional

e trilha de auditoria.

2

10. Referências técnicas específicas e rastreáveis

World Allergy Organization — Anaphylaxis Guidance 2020 — https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7607509/

Anvisa — VigiMed — https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/fiscalizacao-e-monitoramento/notificacoes/vigimed